

CASO CLÍNICO

- **Análisis del caso:**

1. Información personal

Px: Zapana Vega Amaralyna
hc: 429649
Edad: 22 años
Sexo: Femenino
GI: secundaria completa
Procedencia: Villa Maria del Triunfo
Cuenta con servicios básicos
Uso de silla de ruedas eléctrica
Alergia(s): clindamicina

2. Financiamiento

La paciente presenta Atrofia muscular espinal (enfermedad crónica) por lo que requiere múltiples intervenciones como terapia física, ocupacional y evaluaciones de salud en cardiología y neurología. A pesar de que no se cuenta con el financiamiento específico, por su seguimiento médico es posible inferir que requiere de citas médicas continuas. El uso de silla de ruedas eléctrica y concurrencia a terapia requiere de recursos que se brindan incluso con programas de apoyo o seguros ya sea SIS, EsSalud o recursos propios para complementar y mejorar la calidad de vida de la paciente. Por lo que el financiamiento puede variar entre la continuidad de asistencia médica, la adquisición de dispositivos y atención.

3. Diagnóstico e historial médico

Diagnóstico principal:

- Escoliosis neuromuscular por atrofia muscular espinal

Curvaturas severas

- Lateralización dorsal alta derecha, ángulo de Cobb 62, ápex D4, RV
- Lateralización lumbar izquierda, ángulo de Cobb 88, ápex L1, rotación vertebral IV

Diagnósticos secundarios

- Atrofia muscular espinal
- Comunicación interauricular
- Neumonía

Evolución de la enfermedad

- A los 8 meses y medio, retraso en control de tronco; 2 años, se confirma atrofia muscular espinal; 10 años, se diagnosticó escoliosis neuromuscular; en el año 2014 se le detectó un episodio de neumonía y en 2017 se le diagnosticó comunicación interauricular.

Tratamiento actual

- Terapia física
- Terapia ocupacional
- Interconsulta a cardiología y neumología
- Evaluación para ver la posibilidad de corsé rígido

Pronóstico

- Crónico y progresivo, debido a la naturaleza degenerativa de la atrofia muscular espinal.

Riesgo

- Mayor deformidad vertebral
- Compromiso respiratorio
- Disminución funcional progresiva
- Dependencia funcional alta, debido al uso de la silla de ruedas
- Contraindicaciones y precauciones

Evitar dispositivos que

- Comprometan la respiración
- Generen presión prolongada, debido a las úlceras

Precaución

- Equipos de bipedestación sin control postural adecuado
- Terapias intensivas sin monitorio cardiopulmonar

Cirugías

- Pasadas: no hay ninguna

Futuras:

- Se especula de una corrección quirúrgica de escoliosis, considerando las evaluaciones cardiopulmonares.

Medicamentos

- No se especifican en el caso clínico
- Importante: alergia a clindamicina

Molestias del paciente

- No se reporta en el caso clínico un dolor específico

Posibles molestias asociadas a

- Deformidad postural
- Contracturas
- Posición prolongada en silla de ruedas

Función motora oral

- No se reportan alteraciones
- Paciente: orientada y colaboradora adecuadamente

Estado cardíaco y respiratorio

- FC: 70 lpm
- FR: 18 rpm
- Antecedentes de comunicación interauricular y de neumonía
- Pendiente evaluación cardiopulmonar
- Riesgo de compromiso respiratorio por atrofia muscular espinal

Función intestinal y vesical

- Orina: normal
- Deposiciones: normales
- Requiere asistencia para ir al baño

4. Estado Psicosocial

Interacción social, comunicación, cognición

- Paciente orientada en tiempo, espacio y persona, lo que indica adecuada función cognitiva.
- Se muestra colaboradora durante la evaluación, lo que sugiere buena interacción social.
- No se reportan alteraciones en el lenguaje o comunicación, según el caso clínico.

Conciencia de seguridad y juicio

- Presenta adecuado nivel de conciencia
- Juicio aparentemente conservado
- Requiere supervisión en actividades físicas debida a su limitación motora severa.

Comportamientos y rasgos de personalidad

- Actitud cooperativa y participativa durante la evaluación.
- No se describen alteraciones conductuales.

- Posible adaptación psicológica a su condición crónica

Motivación, aprendizaje y sistema de apoyo

- Muestra disposición para colaborar
- Nivel educativo: secundaria completa
- Requiere apoyo constante para actividades básicas

Actitud y tolerancia a la tecnología

- Usa silla de ruedas eléctrica, lo que demuestra:
- Adaptación al uso de tecnología asistida
- Probable buena tolerancia y aceptación
- Potencial candidata a más ayudas tecnológicas

Situación de vida y entorno

- Procedencia: Villa María del Triunfo
- Cuenta con servicios básicos
- Vive en entorno que permite cuidado, aunque con posibles limitaciones de accesibilidad

Dinámica familiar

- Requiere asistencia para higiene y traslado
- Presencia de cuidadores/familia activa en su atención.
- Posible rol importante de la familia en adherencia al tratamiento.

Educación, vocación y empleo

- Educación: secundaria completa.
- No se reporta actividad laboral actual.
- Limitaciones físicas severas pueden restringir opciones laborales tradicionales.

Recreación

- No especificadas en el caso.
- Probablemente limitadas por movilidad reducida.
- Posibles actividades:
- Uso de dispositivos electrónicos
- Actividades sedentarias recreativas

Rutina diaria, actividades y equipo utilizado

- Usa silla de ruedas eléctrica como medio principal de movilidad.
- No deambula.
- Requiere ayuda para:
- Traslado al baño
- Higiene personal

Posición preferida

- Principalmente en sedente
- Logra control de tronco en esta posición.
- Presencia de deformidades por la escoliosis puede influir en postura habitual.

5. Estado neuromuscular y musculoesquelético

Peso: 50 Kg

Talla: 1.44m

HALLAZGOS FÍSICOS:

No camina, rodillas en flexión de 20° no reducible, pies en equino (Plantiflexión), Control de tronco en sedente, hombro izquierdo descendido, asimetría del talle, test de Adams positivo, escoliosis dorsal derecha y lumbar izquierda con ángulos de Cobb de 62° y 88°.

FUERZA MUSCULAR:

Miembros superiores

- Flexión de hombro: 0/5
- Flexión de codo: 1/5
- Flexión de muñeca: 3/5
- Flexión de falange distal: 3/5
- Abducción del 5to dedo: 1/5

Miembros inferiores

- Flexión de cadera: 1/5
- Extensión de rodilla : 1/5
- Dorsiflexión: 1/5
- Plantiflexión: 1/5
- Extensión de hallux: 0/5

6. Afección de la piel

Si bien el caso no menciona alguna presión en la piel que pueda generar úlceras, pero si menciona que usa silla de ruedas por lo que podría llegar a generar:

- Úlceras en la piel
- Irritación
- Problemas de circulación
- Puntos de presión en pelvis, talones o espalda

7. Función sensorial

La función sensorial se encuentra conservada, ya que la Atrofia Muscular Espinal afecta únicamente a las motoneuronas sin comprometer las vías sensitivas. La paciente percibe normalmente los estímulos y se encuentra orientada.

- Función sensorial conservada.
- Percibe dolor, tacto, temperatura y propiocepción.
- Paciente orientada.

8. Habla, lenguaje y comunicación

La paciente presenta un lenguaje conservado, evidenciado por su capacidad para comprender indicaciones y responder de manera adecuada durante la evaluación. Esto sugiere que tanto el lenguaje receptivo como el expresivo se encuentran funcionales.

En cuanto al habla, no se reportan alteraciones en la articulación, por lo que se considera funcional y efectiva para la comunicación diaria. Además, se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona, lo que indica un adecuado

nivel cognitivo. Durante la evaluación, la paciente mostró capacidad de atención y disposición para colaborar, lo cual refuerza la idea de que sus funciones cognitivas están preservadas.

Por lo tanto, la paciente mantiene una comunicación efectiva con su entorno, sin necesidad de utilizar sistemas alternativos o aumentativos de comunicación.

9. Desempeño funcional

Desempeño funcional limitado por la AME (Atrofia Muscular Espinal), con dependencia en actividades básicas; conserva leve funciones distal y usa silla de ruedas eléctrica.

- Dependencia en actividades básicas.
- No deambula.
- Uso de silla de ruedas eléctrica.
- Función distal parcial en manos.

10. Movilidad personal

La paciente tal como nos menciona el caso, no puede caminar, usa silla de ruedas eléctrica, permanece sedente, presenta escoliosis severa y *deformidades en miembros inferiores, por lo tanto su movilidad depende completamente de la silla de ruedas, y es muy importante el posicionamiento correcto para evitar empeorar la escoliosis.

11. Transporte comunitario

La paciente necesita el soporte y la disponibilidad de recursos necesarios que se acomoden a sus necesidades actuales que, aunque limitadas, deben de ser consideradas considerando que, un importante porcentaje de la población usa silla de ruedas, exactamente la paciente se encuentra dentro de las 932 mil personas en el Perú que presentan discapacidad para moverse por sí solas, entonces, considerando esto y el lugar de residencia, debería de ser llevada por algún familiar si es que tuviera un vehículo propio, de lo contrario, usar el metropolitano pues, este incluye lugares designados para la silla de ruedas y personal capacitado para brindar atención, necesita asimismo que las instalaciones de transporte tengan la opción de una rampa o tecnología necesaria para minimizar el esfuerzo y poder posicionar de forma correcta la silla de ruedas

- Si el viaje en silla de ruedas en un vehículo en movimiento: sistema de sujeción de la silla de ruedas y del ocupante (WTORS), y se necesita de un equipo de posicionamiento adicional, colocación en el vehículo, así también del almacenamiento de la silla de ruedas y otros equipos de tecnología de asistencia durante el transporte.
Durante el viaje es necesario un cinturón pélvico (lap belt) el cual va sobre la pelvis (no el abdomen) Debe estar ajustado, bajo y firme. Y un cinturón de hombro (shoulder belt) que cruza el pecho y el hombro y se conecta al sistema del vehículo, no a la silla Soportes laterales del tronco

- De necesitar también cabe la opción de los cinturones posturales.
- En el carro propio si se mueve usando un vehículo autónomo es necesario que este posea:
Reposacabezas, soportes de pies, un arnés torácico y en el maletero o zona designada este la silla fijada con correas o soportes.

12. Entorno

La paciente vive en Villa Maria del Triunfo y cuenta con servicios básicos, lo que brinda condiciones adecuadas para su cuidado.

- Presenta dependencia para actividades básicas como la higiene y uso del baño.
- Cuenta con apoyo familiar y cuidado constante.
- Usa silla de ruedas eléctricas para moverse.
- Acceso a terapia física y ocupacional

13. Historial de equipos anteriores

Debido a la progresión de la atrofia muscular espinal (AME), la paciente ha requerido el uso de ayudas técnicas a lo largo del tiempo.

- Uso actual de silla de ruedas eléctricas
- Dependencia progresiva en la movilidad
- Probable uso o consideración de soportes posturales
- Evaluación actual para posible corsé rígido

14. Equipo actual

La paciente utiliza una silla de ruedas eléctrica como principal medio de movilidad, ya que no puede caminar.

Este equipo le permite desplazarse y mantenerse en una posición sedente, lo cual es importante porque presenta debilidad muscular tanto en miembros superiores como inferiores.

En el caso no se especifican datos como marca, modelo o características técnicas de la silla, ni tampoco información sobre su antigüedad o mantenimiento.

El uso de la silla de ruedas eléctrica está justificado por su condición, ya que facilita su movilidad y le permite participar en sus actividades diarias dentro de sus limitaciones. No se mencionan tampoco gustos, incomodidades o dificultades en el uso del equipo por parte de la paciente.

En general, la silla cumple una función importante en su vida diaria, siendo su principal apoyo para la movilidad.